

누공(fistula)은 연결되어서는 안 되는 두 장기 사이에 생긴 비정상적인 작은 통로입니다. 골반에서는 방광(또는 요관·요도)과 질 사이에 생겨 소변이 지속적으로 새어 나오거나, 직장과 질 사이에 생겨 가스나 대변이 질로 나오기도 합니다. 누공은 저절로 잘 낫지 않지만, 수술로 교정할 수 있습니다.

이 질환에 대하여

- **비뇨생식기 누공** (예: 방광질누공) — 낮과 밤을 가리지 않고 질에서 소변이 **지속적·무의식적으로 새어 나옵니다**.
- **직장질누공** — 질을 통해 **가스나 대변이 나오고**, 반복적인 감염과 자극이 생깁니다.

증상은 고통스럽고 고립감을 줄 수 있지만, 이는 배관 문제처럼 해결책이 있는 신체 이상이며, 환자분이 잘못된 것이 아닙니다.

원인

- **골반 또는 부인과 수술** (예: 자궁적출술) — 많은 나라에서 가장 흔한 원인
- **출산** — 특히 분만이 오래 걸리거나 막힌 경우 (전 세계적으로 주요 원인)
- **방사선 치료**, 염증성 장 질환, 감염, 또는 드물게 암

용어 설명

누공(Fistula)

두 장기를 연결하는 비정상적 통로.

방광질누공(Vesicovaginal)

방광과 질 사이의 누공.

직장질누공(Rectovaginal)

직장과 질 사이의 누공.

염료 검사(Dye test)

방광 또는 직장에 색소 액체를 넣어 누공 위치를 확인하는 검사.

방광경 검사(Cystoscopy)

방광 내부를 카메라로 관찰하여 누공 입구를 찾는 검사.

마르티우스 피판(Martius flap)

누공 봉합을 보강하는 데 사용하는 조직 피판.

전환(Diversion)

치유 기간 중 소변이나 대변을 임시로 우회시키는 방법.

고칠 수 있나요? 네 — 대부분의 누공은 수술로 교정할 수 있으며, 많은 환자가 완전히 치유됩니다. 작고 새로 생긴 누공은 도뇨관만으로 저절로 닫히는 경우도 있지만, 대부분은 계획된 수술이 필요합니다. 시기가 중요합니다: 수술 성공률을 높이기 위해 의사는 염증이 가라앉을 때까지 기다리는 경우가 많습니다.

진단 방법

- 신체 검사, 그리고 누공 위치를 정확히 파악하기 위한 **염료 검사**
- **방광경 검사**와 영상 검사로 크기, 위치, 원인 확인
- 원인 질환(방사선 영향, 감염, 염증성 장 질환) 여부 확인

치료 방법

- 1 **보존적 치료** — 작고 최근에 생긴 요로 누공은 수 주간 도뇨관을 유지하면 닫힐 수 있습니다.
- 2 **수술적 봉합** — 질 또는 복부를 통한 접근으로 통로를 층별로 닫습니다.
- 3 **조직 피판** — 특히 방사선 치료 후에는 마르티우스 피판 등 건강한 조직으로 봉합 부위를 보강할 수 있습니다.
- 4 **임시 전환** — 일부 직장질누공의 경우, 봉합 부위 치유를 돕기 위해 대변을 단기간 우회시킵니다.

알아 두세요

- 수술 전까지는 피부를 보호하고 패드를 사용하세요. 편안함을 위한 방법을 의료진과 상의하세요.
- **방사선 치료** 후 누공은 더 복잡하여 조직 피판이 필요한 경우가 많습니다.
- 도뇨관 제거 전 **치유 확인 검사**를 받을 수 있습니다.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 발열 또는 오한, 골반 통증 악화
- 감염 징후 또는 심한 출혈
- 수술 후: 도뇨관 배액 중단, 또는 소변 누출 재발

기억할 세 가지

1. 누공은 소변이 새거나(비뇨생식기) 가스·대변이 질로 나오는(직장질) 비정상적 통로입니다.
2. 대부분 교정 가능합니다 — 일부 소형 누공은 도뇨관으로 닫히지만, 대부분은 조직 피판을 포함한 계획 수술이 필요합니다.
3. 시기가 중요합니다. 의료진이 염증 소실을 기다릴 수 있습니다. 수술 후 발열, 감염 징후, 또는 누출 재발 시 즉시 알려 주세요.